

TEMA 5.21 • OFTALMOLOGÍA

neurooftalmología 3

PERFIL EUNACOM 6.02.2.009

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Neuro-Oftalmología: Semiología y Defectos de las Pupilas

El examen y testeo físico de fotomotor regular biológico, cruzado y reflejos bases luminares, es de enorme utilidad porque discrimina si la disfunción visual de decantación radica primitivamente per se en la incapacidad ocular crasa inicial biótica óptica ciega sensora (Nervio Óptico biótico II Par) vs falla y deficiencia neuromotora central craneal eferente en el tronco respuesta biótica motriz base posterior del (Nervio Oculomotor nervio III Par basal esfínter pupila).

TABLA 5.21.1: VARIANTES PUIPOS CLÍNICOS EUNACOM VS EXAMEN Y RESPUESTAS FÍSICAS DIRECTAS EUNACOM	
VARIANTES PUIPOS CLÍNICOS EUNACOM	EXAMEN Y RESPUESTAS FÍSICAS DIRECTAS EUNACOM
Normalidad Base (Reflejo Consensuado natural sano)	Iluminar base el ojo A contrae vigorosamente en miosis base y paralela al ojo A de golpe perimetral igual como base y en paralelo biótico estricto en miosis consensuada simultánea del ojo B por interconexión quiasmática base.
Defecto Pupilar Aferente (Pupila de Marcus Gunn) <i>(Clásico y patognomónico estricto de base falla directa natural masiva de inflamación en la propia fibra crasa del II Nervio biótico del Nervio Óptico, interrumpiendo el canal del ingreso sensitivo inicial y privando la estimulación refleja del tronco).</i>	1. Iluminar base el "ojo sano base" contrayendo miosis reactiva biótica en ambas. 2. Al brincar rápido e iluminando al ojo crasamente enfermo, Aparente dilatarse paradójicamente perimetral y base a midriasis general , (falso en fisiología: solo soltó y devolvió tónicamente y bruscamente base a la oscuridad y miadriasis inicial pasiva el reflejo esfínter inicial del iris ya que nunca llegó al cerebro original mente la luz estimuladora motora del reflejo eferente por desconexión en el ojo base malo iluminado sensorial).
Defecto Pupilar Eferente puro base (<i>Daño franco asimétrico base del componente del trayecto propio del tercer craneal oculomotor III Par o de su esfínter pupilar biótico iris en estricto rigor y aislado basal</i>).	Cursa base en descanso con notoria diferencia general estructural previa base Anisocoria base (Pupila lesionada en Midriasis Fija paralizada base general sin miosis base natural) . Iluminar en directo en cualquiera base de los dos general globo biótico base resultará igual: El base biótico ojo nervio eferente motor normal se contrae en miosis a la luz e impulso, pero base de ojo dañado general y eferente craneal III par paralítico se queda y base perimetral pasivo pasmado tónicamente sin estímulo basal constrictor final miótico en ninguna de las estimulantes directas.

| **Pupila Tónica de Adie** (*Lesión focal autónoma de los ganglios ciliares base parasimpáticos post ganglionares base de la musculatura perimetral motora*).| Cursa también asimétricamente base inicial con **Anisocoria base midriática**. Clínicamente el reflejo fotomotor básico base es extrañamente asimétrico: reacciona y aprieta en miosis la pupila, pero de una forma exagerada, enlentecida perezosamente base a los ritmos, resultando patológicamente menos miosis rápida global base respecto al ojo basal normal (Hipo-reactividad miosis tónica floja parética). |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Un paciente de sesenta años diabético de larga data consulta por visión doble y párpado caído derecho de aparición brusca. Al examen hay ptosis derecha, el ojo derecho está desviado hacia abajo y afuera, y la pupila derecha está dilatada y no reactiva. ¿Cuál es el diagnóstico y la causa más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para neurooftalmología 3. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Parálisis del tercer par craneal: ptosis, midriasis y estrabismo divergente; causa más frecuente es diabetes mellitus.
- Parálisis del cuarto par: imposibilidad de mirar hacia abajo y adentro, el paciente inclina la cabeza al lado contrario.
- Parálisis del sexto par: estrabismo convergente por incapacidad de mirar hacia afuera o lateral.
- Síndrome de Horner: ptosis parcial, miosis y anhidrosis ipsilateral; importante descartar tumor de Pancoast pulmonar apical.
- Pupila de Argyll Robertson es patognomónica de neurosífilis: pierde reflejo fotomotor pero conserva acomodación y convergencia.
- Lagofthalmia por lesión del séptimo par craneal: cierre incompleto del ojo con riesgo de ojo seco por exposición corneal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUROFTALMOLOGÍA 3)**PREGUNTA 1**

Un paciente de sesenta años diabético de larga data consulta por visión doble y párpado caído derecho de aparición brusca. Al examen hay ptosis derecha, el ojo derecho está desviado hacia abajo y afuera, y la pupila derecha está dilatada y no reactiva. ¿Cuál es el diagnóstico y la causa más probable?

- A)** Parálisis del nervio abducente derecho por diabetes; produce estrabismo convergente
- B)** Parálisis del nervio oculomotor derecho por diabetes; produce ptosis, midriasis y estrabismo divergente
- C)** Síndrome de Horner derecho; produce ptosis, miosis y anhidrosis
- D)** Parálisis del nervio troclear derecho; produce estrabismo con imposibilidad de mirar hacia abajo
- E)** Neuritis óptica derecha; produce pérdida visual y defecto pupilar aferente

PREGUNTA 2

Un hombre de cincuenta años fumador consulta por ptosis parcial izquierda, pupila izquierda pequeña y sequedad del lado izquierdo de la cara. Al examen se confirma miosis izquierda con ptosis parcial izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el estudio más importante a realizar?

- A)** Parálisis del nervio oculomotor izquierdo; solicitar resonancia magnética de cerebro
- B)** Síndrome de Horner izquierdo; solicitar radiografía y tomografía de tórax para descartar tumor de Pancoast
- C)** Uveítis anterior izquierda; solicitar anticuerpos autoinmunes
- D)** Glaucoma agudo izquierdo; medir presión intraocular urgente
- E)** Conjuntivitis bacteriana crónica; cultivar secreción conjuntival

PREGUNTA 3

Al examinar la pupila de un paciente con sospecha de neurosífilis, se observa que la pupila no se contrae al iluminarla con una linterna, pero sí se contrae al pedirle que mire un objeto cercano. ¿Cuál es el nombre de este hallazgo y qué indica?

- A)** Defecto pupilar aferente o signo de Marcus Gunn; indica daño del nervio óptico
- B)** Pupila de Argyll Robertson; es patognomónica de neurosífilis
- C)** Pupila de Adie; indica daño del ganglio ciliar
- D)** Síndrome de Horner; indica lesión del ganglio estrellado simpático
- E)** Midriasis farmacológica; indica uso de anticolinérgicos

RESUMEN: NEUROFTALMOLOGÍA 3

Esta clase abarca las parálisis de los nervios craneales encargados de los movimientos oculares, la lesión del fascículo longitudinal medial, el síndrome de Horner, la pupila de Argyll Robertson y la lagofthalmia. El nervio oculomotor o tercer par craneal al paralizarse produce ptosis palpebral, midriasis y estrabismo divergente por predominio del cuarto y sexto par. La causa más frecuente es la diabetes mellitus. El cuarto par craneal o nervio troclear al paralizarse produce imposibilidad de mirar hacia abajo y adentro, con estrabismo divergente leve, el paciente inclina la cabeza al lado contrario. El sexto par craneal o nervio abducente al paralizarse produce estrabismo convergente por incapacidad de mirar hacia afuera o lateral. El fascículo longitudinal medial conecta los centros de la mirada conjugada y su lesión produce oftalmoplejia internuclear con nistagmo al mirar hacia un lado, sin poder mirar hacia medial con el ojo contralateral, pero con convergencia preservada. El síndrome de Horner se produce por lesión del ganglio estrellado o la cadena simpática cervical. Produce ptosis parcial, miosis y anhidrosis ipsilateral. Es importante porque puede ser marcador de tumor pulmonar apical como el tumor de Pancoast. La pupila de Argyll Robertson es patognomónica de neurosífilis: pierde el reflejo fotomotor pero conserva el reflejo de acomodación y convergencia. La lagofthalmia es el cierre incompleto del ojo por lesión del nervio facial séptimo par, que inerva el músculo orbicular, y puede producir ojo seco por exposición corneal.